Fora INNOVATING HEALTHCARE MANAGEMENT
5ο ΥΒΡΙΔΙΚΟ FORUM
ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026
Ώρα 10:00 -17:00
Divani Caravel Hotel, Βασ. Αλεξάνδρου 2, Αθήνα

Από τα Νέα Μοντέλα Φροντίδας στην Πραγματική Εφαρμογή

Ε. Θηραίος MD, MSc in Public Health, PhD
Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός – Δ/ντής ΕΣΥ
Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης - Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.)
Πρόεδρος Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
Επιστημονικός Συνεργάτης Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης στη Δημόσια Υγεία της Ακαδημίας Αθηνών

ΟΔΙΠΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 1835

Από την τεκμηριωμένη φροντίδα …

Οι προκλήσεις …

Ageing Population

- Increasing number of patients with chronic diseases
- Increasing need for resources

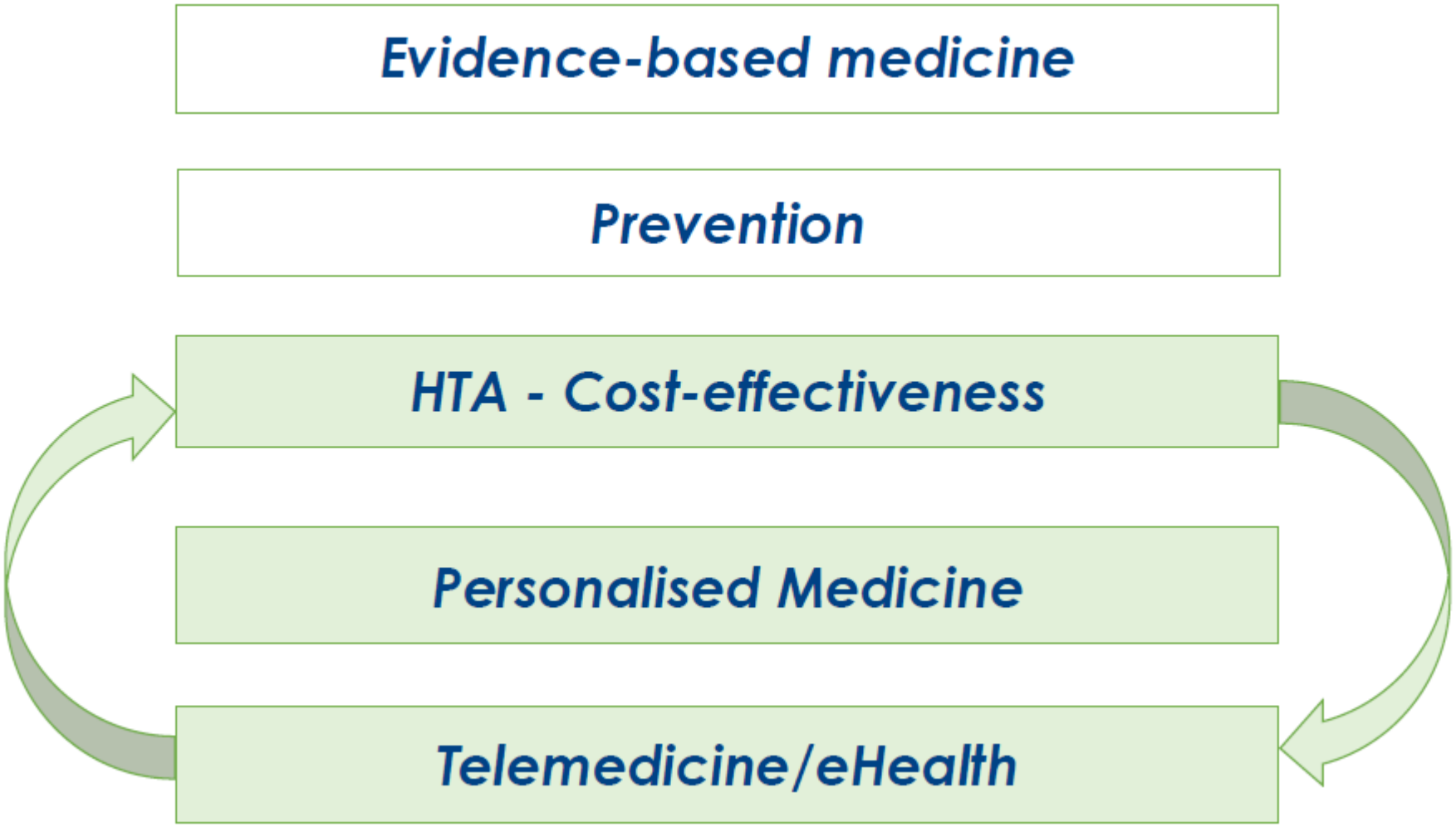
Financial Crisis

- Decreasing supply of human and other resources

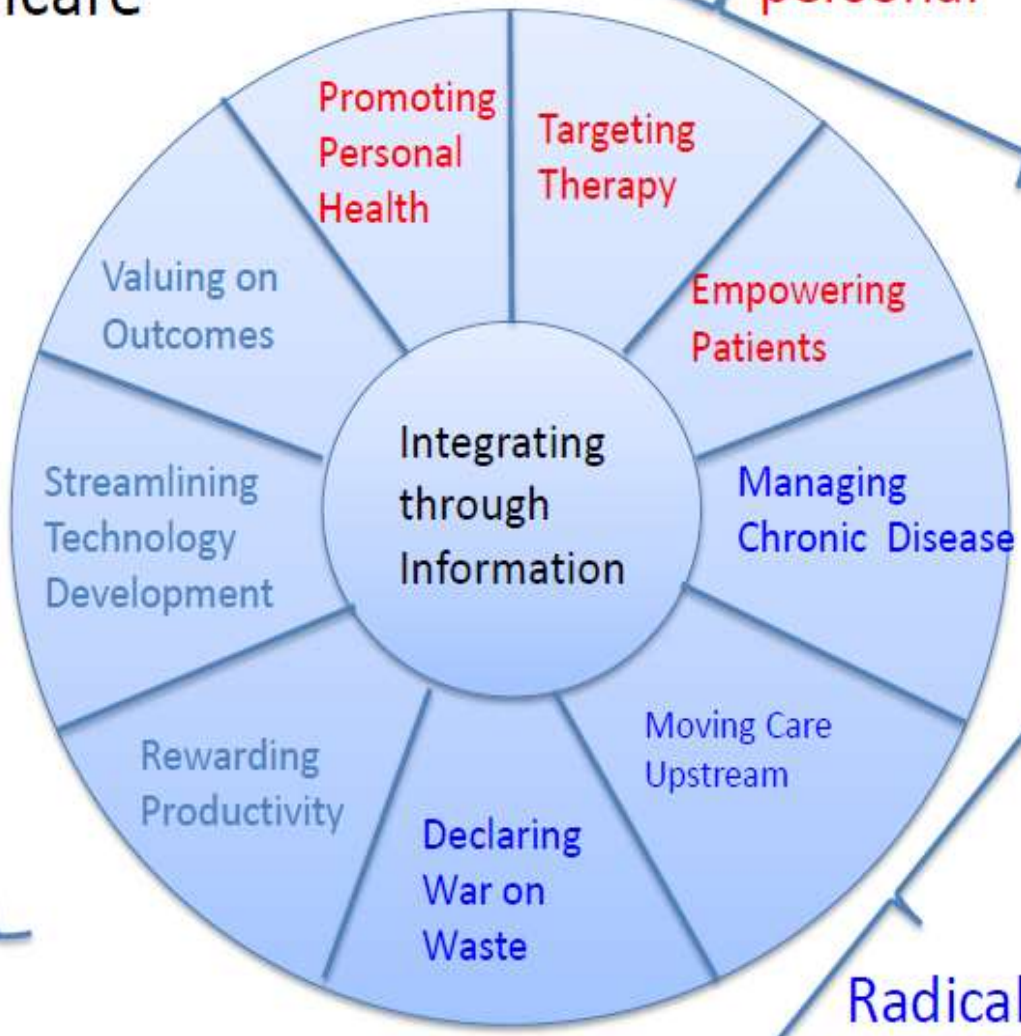
CVD, DM, COPD: major economic burden (>€350 billions)

Costly organisations & health care systems

Οι στρατηγικές …



Information the Key to Greater Healthcare Productivity



Making healthcare really personal

Focusing on productivity and performance

Radically redesigning healthcare delivery

Barker, 2030 – The Future of Medicine OUP, 2011)

Challenges along a patient's journey

Awareness



Early symptoms not recognized

Diagnosis



Diagnostics not part of all check-ups or not reimbursed



Poor physician-patient communication

Therapy

Complex medication for co-morbid patients



Side effects and drug-drug interactions





Intentional & non-intentional non-adherence

Fear & anxiety



Monitoring

Social withdrawal, avoidance, isolation



myHealth
Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας

MyHealth
Εφαρμογή πολιτών



Δεδομένα

Γυναικολογικό Ιστορικό

Συνταγές & Παραπεμπτικά
Φάρμακα, εξετάσεις, παρατηρήσεις ιατρού

Βεβαιώσεις
Ιατρικές, Αναρρωτικές, Εξετάσεων για Διπλώματα Οδήγησης & Κυοφορίας

Εμβολιασμοί
Παιδικοί εμβολιασμοί, Γρίπης & Covid19

Χειρουργεία
Ιστορική ανάκτηση προηγούμενων αλλά και μελλοντικών χειρουργείων

Ραντεβού
Προβολή ιατρικών ραντεβού σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Ιατρικό Προφίλ & Αλλεργίες
Προσωπικά Στοιχεία, Κοινωνικοί Παράγοντες, Οικογενειακό Ιστορικό, Ένταξη σε Μητρώα, Μετρήσεις, Αλλεργίες

Μητρώα Υγείας
Νωτιαίας Μυϊκής Ατροφίας, Κυστικής Ίνωσης, Παιδικών Νεοπλασιών κ.α.

Αποτελέσματα εξετάσεων
Αποτελέσματα εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων

Πρόσβαση από επαγγελματία υγείας
Προβολή πλήρους ιστορικού πρόσβασης από επαγγελματίες υγείας.

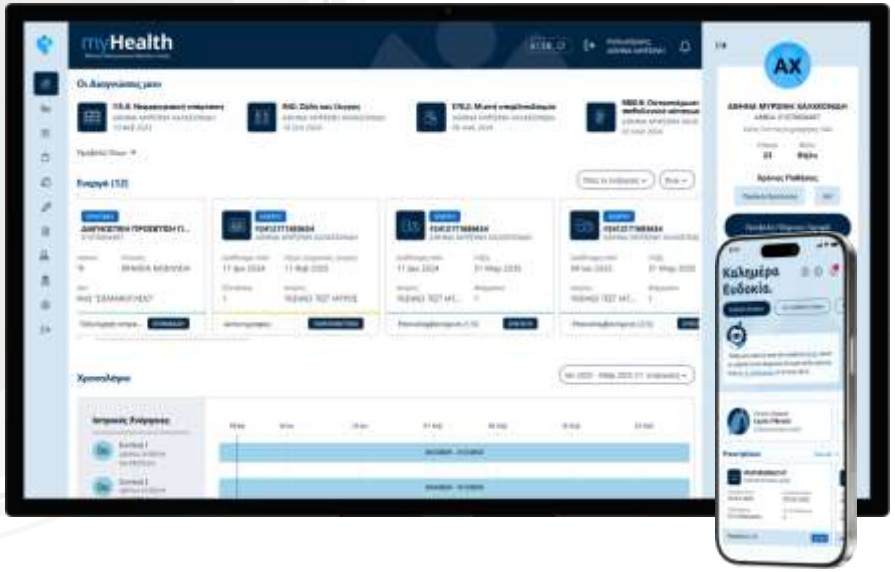
Οικογένεια μου
Πληροφορίες για εμένα και τα εξαρτώμενα μέλη μου

Ειδοποιήσεις
Λήψη ειδοποιήσεων έκδοση συνταγών, παραπεμπτικών και έκδοση αποτελεσμάτων εξετάσεων

Διαγνώσεις
Οι διαγνώσεις από όλες τις ενότητες του φακέλου σε μια σελίδα.

Παιδιατρικό Ιστορικό

Χρονολόγιο
Όλες οι προγραμματισμένες ενέργειες σε ένα μοντέρνο χρονολόγιο



Η Κλινική Διακυβέρνηση …

Ανάπτυξη προτύπων Κλινικής Διακυβέρνησης (Clinical Governance),

το φάσμα δηλαδή των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας σε ένα σύστημα υγείας, με όρους αποτελεσματικής διαχείρισης των προβλημάτων υγείας των ασθενών και αποδοτικής χρήσης των πόρων.



Εργαλεία Κλινικής Διακυβέρνησης

- Μέτρηση της αξίας των παρεμβάσεων (Value Based Health Care) προς όφελος του ασθενή.
- Κύρια στοιχεία αυτών των παρεμβάσεων αποτελούν:
  - η Κλινική Αποτελεσματικότητα και Τεκμηριωμένη Ιατρική Φροντίδα (Evidence-based Care),
  - τα Θεραπευτικά-Κλινικά Πρωτόκολλα και Κλινικές Οδηγίες,
  - η ανάπτυξη Μητρώων Δεδομένων Ασθενών (Patient Registries)
  - η υιοθέτηση Δεικτών Ποιότητας και Αξιολόγησης της Απόδοσης του Κλινικού Έργου (Clinical/Medical Audit, KPIs),
  - η Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας (HTA) και DRGs

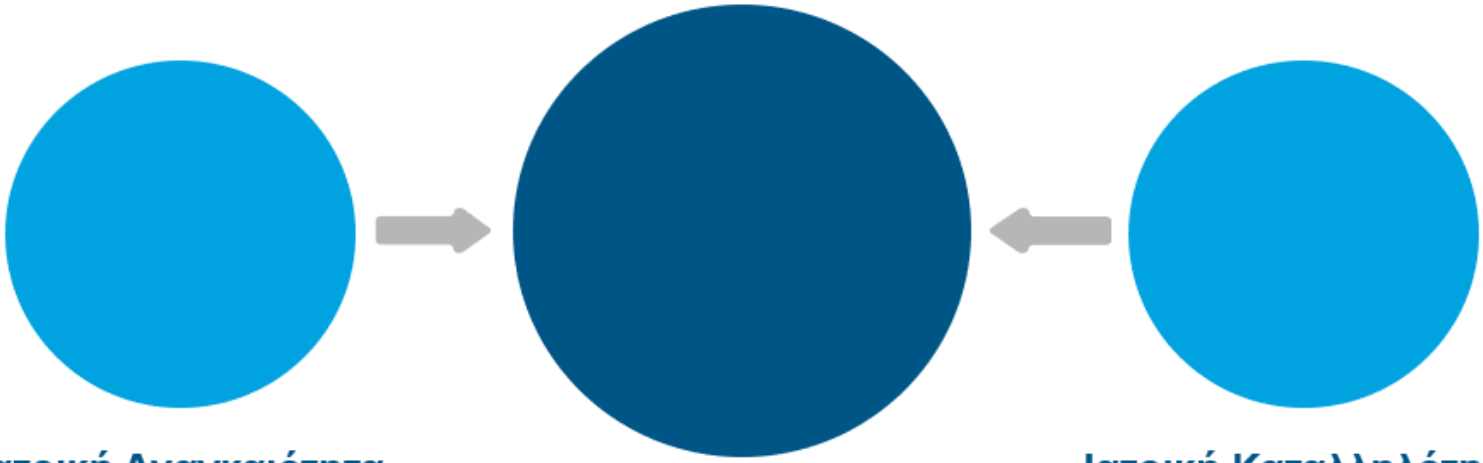
  για τον εξορθολογισμό της δαπάνης και τον προσδιορισμό του κόστους διαχείρισης των νοσημάτων
  - η ανάπτυξη ενός σύγχρονου Business Intelligence and Management Information System για το Υπουργείο
  - η ανάπτυξη Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή,
  - η εφαρμογή Προτύπων Διασφάλισης της Ποιότητας (Quality Assurance),

  για την πρόσβαση στα δεδομένα υγείας και την αποτελεσματική διαχείρισή τους

στο πλαίσιο μιας **Ηλεκτρονικής Κλινικής Διακυβέρνησης**.

Γιατί χρειαζόμαστε τον Κλινικό Έλεγχο (Clinical audit);

Στόχοι Κλινικού Ελέγχου



Ιατρική Αναγκαιότητα (Medical Necessity)

Παροχή της **αναγκαίας φροντίδας** με **επιστημονική τεκμηρίωση,**

όφελος για τον ασθενή, αύξηση της **ικανοποίησής** του και με

οικονομικά αποτελεσματικό τρόπο.

Κλινικός Έλεγχος (Clinical audit)

Ιατρική Καταλληλότητα (Medical Appropriateness)

Αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας βάσει:

- Της κάλυψης **βασικών αναγκών** περίθαλψης βάσει **διάγνωσης**
- Οικονομικής **αποδοτικότητας**
- Της κατάλληλης **υποδομής υγείας**
- **Πρωτοκόλλων** Αποδεδειγμένης **αξίας**

Ελληνικό Σύστημα DRG

ΟΔΙΠΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Πληροφοριακό Μέρος

- Λογισμικό Κοστολόγησης
- Λογισμικό Κωδικοποίησης
- Λογισμικό Ταξινόμησης- grouper

Υποστήριξη Συστήματος DRG



Οικονομικό Μέρος

Example: InEK cost matrix



DRG I95Z *Implantation of a tumor endoprosthesis*, cost average 18.286€

- Μέθοδος υπολογισμού κόστους
- Cost Matrix
- Δεδομένα

Οδηγίες τιμολόγησης (Billing Guidelines)
Οδηγίες κοστολόγησης

Συντελεστές βαρύτητας κόστους

Ιατρικό Μέρος

- Εξειδικευμένες Διαγνωστικές Μέθοδοι
- Ιατρικές Διαγνώσεις ICD-10
- Ιατρικές Πράξεις - Ειδικές Θεραπείες

- Οδηγίες κωδικοποίησης (Coding Guidelines) ιατρικών κωδικοποιήσεων

Ταξινόμηση Ασθενών


Cost effectiveness
Clinical effectiveness

… στις αναγκαίες πολιτικές υγείας

Οι αναγκαίες υποδομές



Οργανισμός Διασφάλισης Ποιότητας Υγείας:

- **Μητρώα-Κωδικοποιήσεις**
- **Εθνικές Προδιαγραφές**
- **Πιστοποίηση Πληρ. Συστημάτων**
- **Υλοποίηση Εθνικής Στρατηγικής για την Ψηφιακή Υγεία**

Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας

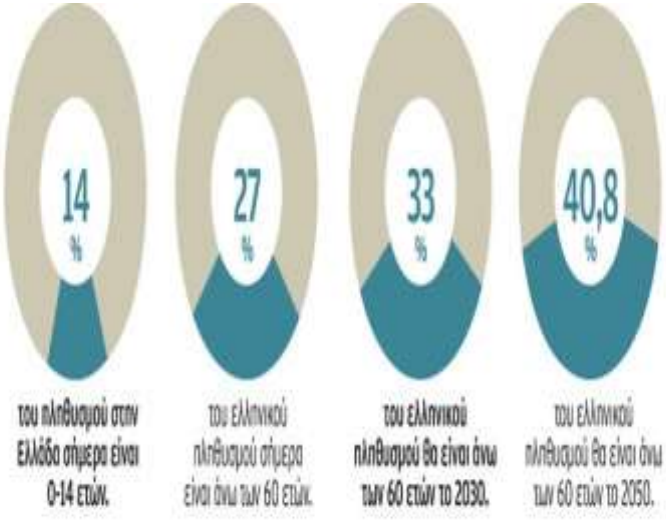
Ακολουθώντας το μοντέλο του έργου SRSS, κάποια use cases (π.χ. εργαστηριακές εξετάσεις και ραντεβού) **μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα**

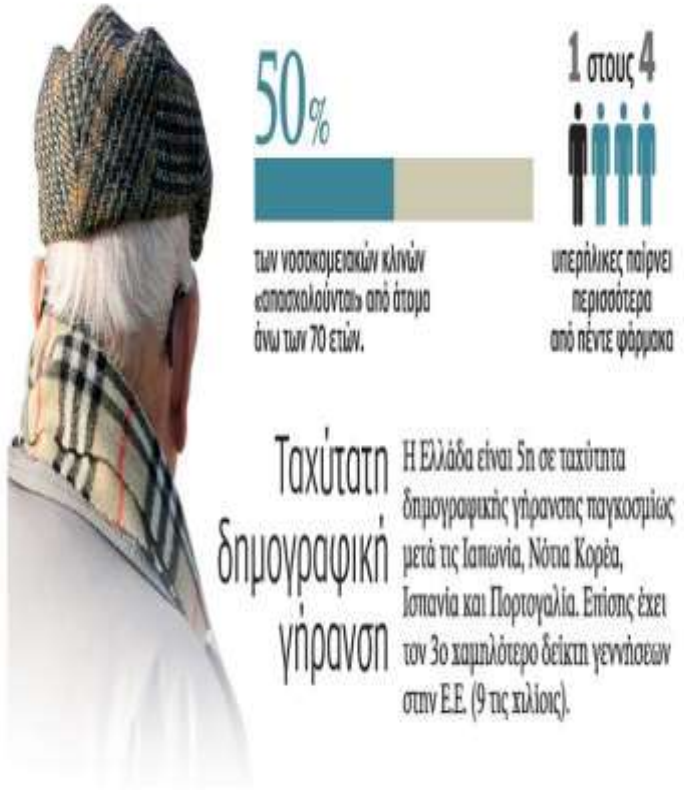
Αποθετήριο Κλινικών εγγράφων στην Η.ΔΙ.Κ.Α.

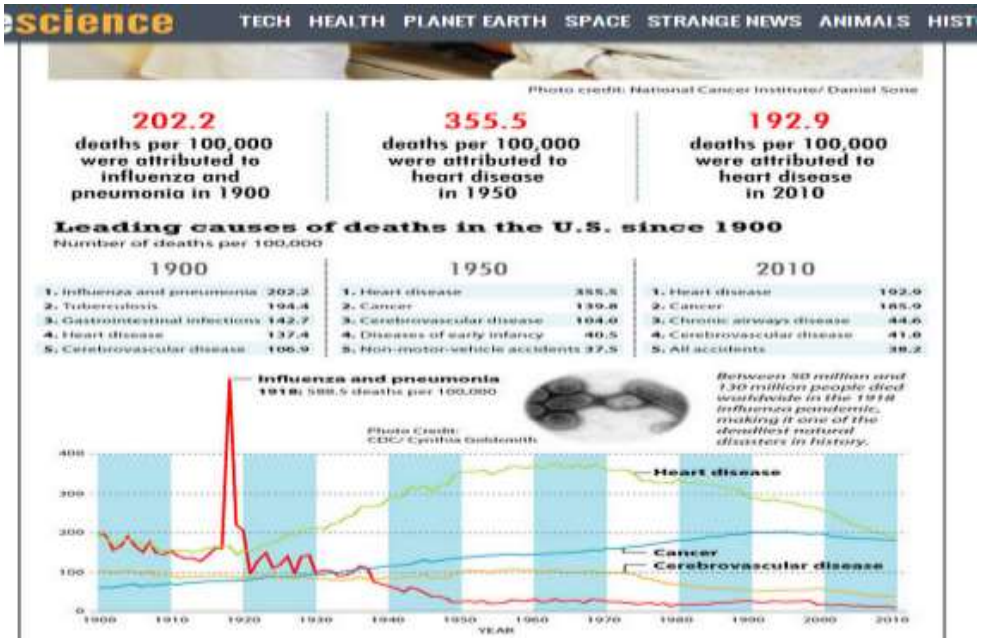
Βασισμένο σε διεθνή πρότυπα διαχείρισης κλινικών εγγράφων , που θα φιλοξενήσει καταρχήν τις εργαστηριακές εξετάσεις και θα επεκταθεί σταδιακά σε πορίσματα απεικονιστικών εξετάσεων, εξιτήρια κ.λ.π.

Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο Πολίτη:

- Πολυκαναλική πρόσβαση στα δεδομένα
- Πρόσβαση στα δεδομένα του σε κάθε μονάδα υγείας





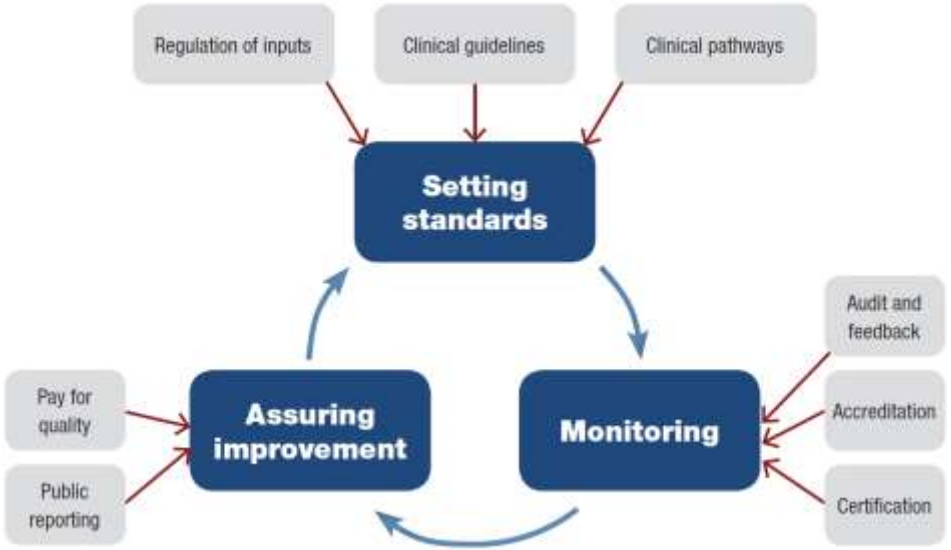


Ο βαθμός συντονισμού/ ολοκλήρωσης μεταξύ των φορέων α'βάθμιας και β' βάθμιας φροντίδας είναι χαμηλός. ***Ένα μεγάλο ποσοστό χρονίως πασχόντων καταλαμβάνει μεγάλο ποσοστό των κλινών οξείας νοσηλείας στα δημόσια Νοσοκομεία***

Πάνω από το 1/3 των εισαγωγών έκτακτης ανάγκης σε ένα γενικό νοσοκομείο θα μπορούσαν να αντιμετωπίζονται από **υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας**

Ποιότητα ΥΥ: Εργαλείο για την βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας





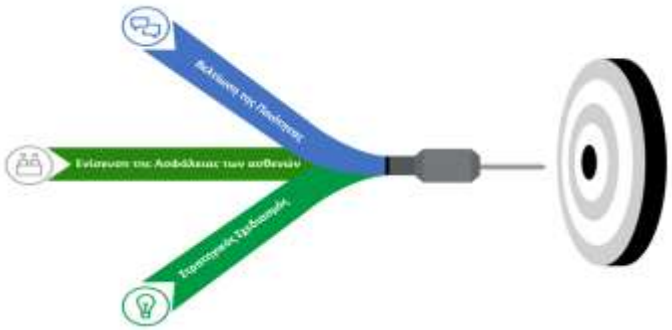
Είναι χαμηλή η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα;

1η απάντηση: Δεν έχουμε συμφωνήσει στο τι ορίζεται ποιότητα

- UK: doing the right things to the right people at the right time.
- Avedis Donabedian: the degree to which it conforms to pre-set standards of care.

2η απάντηση: Ποιος θα αξιολογήσει την ποιότητα, με ποια μεθοδολογία και με ποια μέτρα;

Ο ρόλος του ΟΔΙΠΥ …



Στόχοι του Οργανισμού

01. Βελτίωση της Ποιότητας των Παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας, μέσω της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού, της προτυποποίησης της φροντίδας και της υιοθέτησης & εφαρμογής Δεικτών Μέτρησης Ποιότητας & Ασφάλειας.

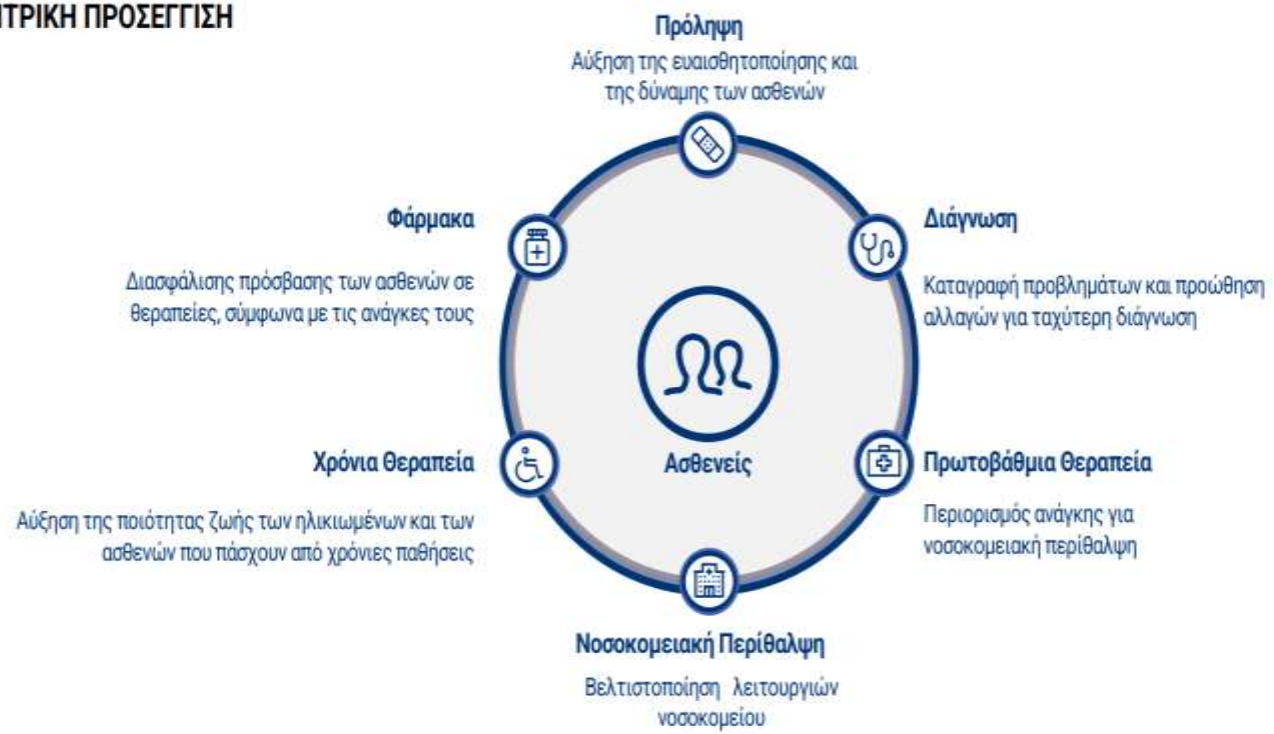
02. Ανάπτυξη & Ενίσχυση της κουλτούρας ασφάλειας μέσω της ενεργούς συμμετοχής ασθενών και εργαζομένων στον σχεδιασμό της φροντίδας με επίκεντρο τον ασθενή.

03. Αναβάθμιση & Αναδιοργάνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς.

… με στόχο την ισότιμη πρόσβαση και την καθολική κάλυψη του πληθυσμού

… με βασικά εργαλεία

ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ



Ψηφιοποίηση
Επανασχεδιασμός των βασικών συστημάτων υποστήριξης των ασθενών και αλληλεπίδρασης μαζί τους για να οικοδομηθούν τα θεμέλεια της επικοινωνίας. Ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών και βελτίωση των χειροκίνητων ροών εργασίας με νέα ψηφιακά συστήματα.

Εστίαση στην εμπειρία των ασθενών
Ενεργοποίηση εξατομικευμένων διαδρομών ασθενών, ροών εργασίας και αλληλεπιδράσεων σε αυτές τις διαδρομές. Επανεστίαση των ψηφιακών διαδικασιών και συστημάτων για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων που ενισχύουν την κατανόηση της εμπειρίας του ασθενούς.

Ακρίβεια στην αλληλεπίδραση με τους ασθενείς
Αξιοποίηση των δεδομένων που συλλέγονται από τις αλληλεπιδράσεις με τους ασθενείς, για πληροφορίες και στοιχεία που ενημερώνουν στοχευμένες παρεμβάσεις και ενθαρρύνουν τις συμπεριφορές που οδηγούν στα επιθυμητά αποτελέσματα για την υγεία.

- ## Ανάπτυξη Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης Μονάδων Υγείας
  - Βάσει προτύπων, κριτηρίων, πολιτικών, διαδικασιών ποιότητας και η μέτρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της χρήσης αντικειμενικών και αξιόπιστων δεικτών.

- ## Ανάπτυξη ενός Εθνικού Χάρτη Υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας
  - Θα παρέχεται έτσι η δυνατότητα για τη συνδυασμένη αποτύπωση των στοιχείων:
    - των αναγκών υγείας του πληθυσμού και της ζήτησης για υπηρεσίες υγείας (π.χ. διαπεριφερειακές ροές, στοιχεία νοσηρότητας και θνησιμότητας καθώς και αυτοαναφορές εκτίμησης της κατάστασης της υγείας και νόσησης από διάφορες χρόνιες παθήσεις)
    - της προσφοράς των υπηρεσιών υγείας (πχ ημέρες νοσηλείας, αριθμός νοσηλευμένων, αριθμός κλινών, ανθρώπινο δυναμικό και εξαγωγή συναφών δεικτών π.χ. πληρότητα, ΜΔΝ κ.ά.)
    - των δεικτών ποιότητας (ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας)

- ## Προτυποποίηση της φροντίδας των ασθενών και ανάπτυξη δικτύων ολοκληρωμένης φροντίδας
  - Ανάπτυξη Δικτύων Ολοκληρωμένης Φροντίδας για ασθενείς με χρόνια νοσήματα, που θα περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα φροντίδας, με την ΠΦΥ να αποτελεί την πύλη εισόδου στο σύστημα υγείας
  - Προτυποποίηση της φροντίδας στο μονοπάτι (pathway) των ασθενών
  - Βελτίωση της ποιότητας και εφαρμογή κλινικών οδηγιών και πρωτοκόλλων στο πλαίσιο μιας Κλινικής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων (eHealth) και με επένδυση στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, τη διεπαγγελματική συνεργασία, την εκπαίδευση και την ψηφιακή εγγραμματοσύνη
  - συνέργειες με τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων και τους συλλόγους ασθενών (ΕΑΕ, ΕΛΛΟΚ, ΕΣΑΕ)

Η Πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Ποιότητα

A health care system where quality is a daily commitment, ensuring that all individuals trust health care to be safe, respectful, equitable and efficient

National Strategy for Quality of Care and Patient Safety for Greece 2025 – 2030



Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης – ΚΠΑ

Δομή Μοντέλου ΚΠΑ:

Το ΚΠΑ περιλαμβάνει:

- **5 Κριτήρια Προϋποθέσεων (Enablers):**
  - (1) Ηγεσία
  - (2) Στρατηγική & Σχεδιασμός
  - (3) Ανθρώπινο Δυναμικό
  - (4) Συνεργασίες & Πόροι
  - (5) Διαδικασίες
- **4 Κριτήρια Αποτελεσμάτων**
  - (6) Αποτελέσματα Πολίτη/Πελάτη
  - (7) Αποτελέσματα Προσωπικού
  - (8) Κοινωνική Ευθύνη
  - (9) Βασικά Αποτελέσματα Απόδοσης

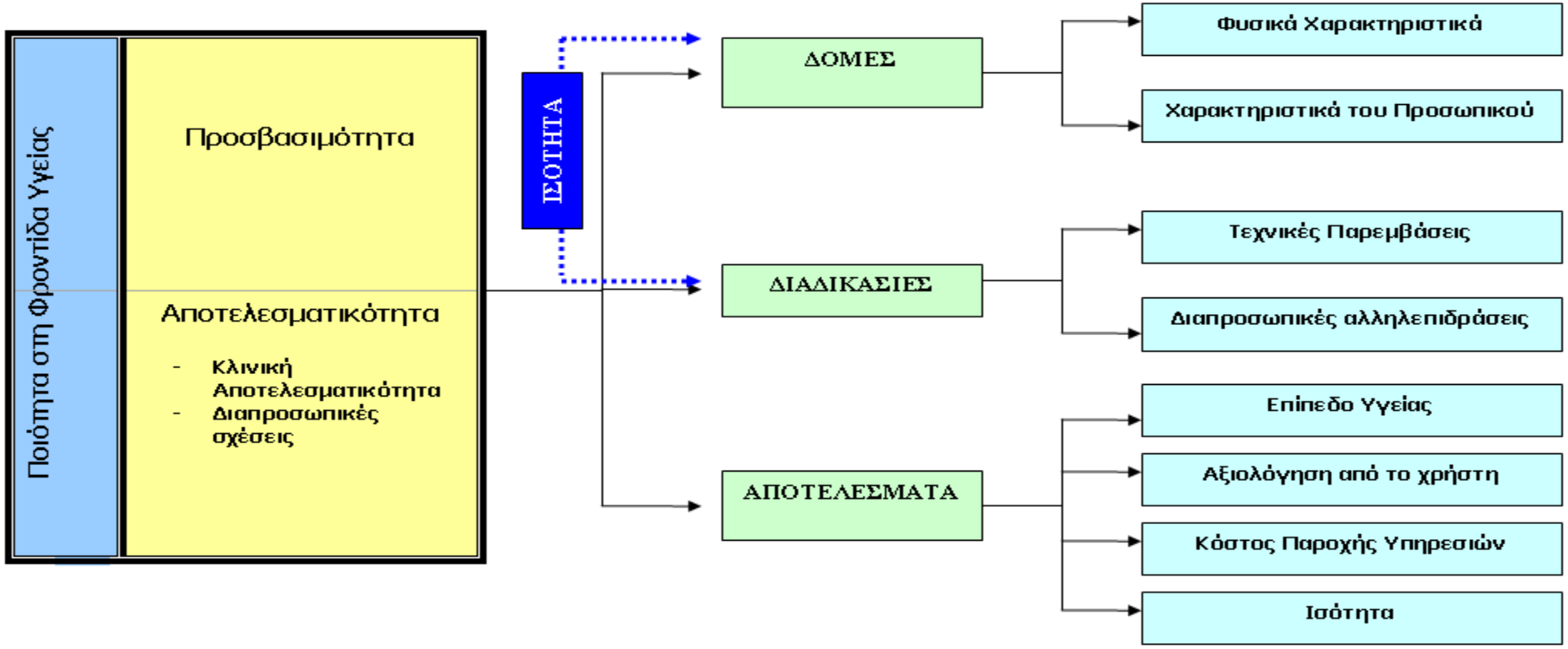
→ 9 Κριτήρια

→ 28 Υποκριτήρια



Αξιολόγηση της ποιότητας της φροντίδας

*Ο βαθμός στον οποίο τα άτομα έχουν **πρόσβαση** σε δομές και διαδικασίες **που έχουν ανάγκη** και στον βαθμό που οι υπηρεσίες που δέχονται αποδεικνύονται αποτελεσματικές*



Campbell SM, Roland MO, Buetow SA (2000). Defining quality of Care. Soc Sci Med. 51:1611-1625



Πλαίσιο Αξιολόγησης Νοσοκομείων Στην Ελλάδα

Α. Αυτοαξιολόγηση των Νοσοκομείων & Αξιολόγηση της Παρούσας Κατάστασης Βάσει Ευρωπαϊκού Προτύπου με επισκέψεις κλιμακίων του ΟΔΙΠΥ

Β. Μέτρηση της Ποιότητας των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών μέσω δεικτών ποιότητας

Γ. Η οπτική γωνία των ασθενών/Μέτρηση εμπειριών και αποτελεσμάτων από τους ασθενείς (PREMs & PROMs)

Ανάπτυξη Εργαλείου Για Την Αυτοαξιολόγηση των Νοσοκομείων & Την Αποτύπωση Της Παρούσας Κατάστασης Βάσει Ευρωπαϊκού Προτύπου

Αξιολόγηση της παρεχόμενης φροντίδας με έμφαση στα αποτελέσματα υγείας

Το Εργαλείο περιλαμβάνει συνολικά 134 κριτήρια αξιολόγησης βάσει των απαιτήσεων που περιγράφονται σε ενιαία πρότυπα ποιότητας (σε ευθυγράμμιση με τις πρωτοβουλίες του ΠΟΥ για την προώθηση της ασφάλειας των ασθενών) που καλύπτουν τους διαφορετικούς τομείς της ασφάλειας των ασθενών:

Patient Safety Assessment manual
Patient Safety Friendly Hospital Assessment

Τομείς

- Ηγεσία και Διοίκηση
- Συμμετοχή ασθενών και κοινού
- Ασφαλείς κλινικές πρακτικές που βασίζονται σε τεκμηριωμένη
- Ασφαλές περιβάλλον
- Δια βίου εκπαίδευση

Πεδία αξιολόγησης

- Εγκαταστάσεις και χώροι νοσηλείας
- Πυρασφάλεια
- Εργαστήρια
- Χειρουργεία και Μον. Αποστείρωσης
- Φαρμακείο
- Αρχεία ασθενών



World World Health Organization. (2020). Patient safety assessment manual.
https://applications.emro.who.int/docs/9789290223221-eng.pdf

ΟΔΙΠΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Αξιολόγηση σε περισσότερα από 70 Νοσοκομεία

Μέτρηση Δεικτών Ποιότητας και Ασφάλειας Ασθενών σε 11

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ	
1	**Συμμόρφωση** (ικανοποιείται το κριτήριο- υπάρχουν σχετικές αρμοδιότητες/ διαδικασίες- επαλήθευση εφαρμογής)
2	**Μερική συμμόρφωση** (δεν ικανοποιείται: τεκμηρίωση/ αποτελεσματικότητα εφαρμογής- απαιτούνται παρεμβάσεις βελτίωσης)
3	**Μη συμμόρφωση** (παντελής έλλειψη εφαρμογής)
4	Δεν είναι εφαρμόσιμο το κριτήριο/ δεν αξιολογείται λόγω ελλιπών στοιχείων



Ανάπτυξη Δεικτών Ποιότητας και Ασφάλειας Ασθενών και Μεθοδολογικού Οδηγού



40 δείκτες ποιότητας (δομής, διαδικασιών και αποτελεσμάτων)



Ανάπτυξη Δεικτών Ποιότητας και Ασφάλειας Ασθενών

Ταξινόμηση Δεικτών Ποιότητας της παρεχόμενης Φροντίδας και Ασφάλειας Ασθενών

	Δείκτες Δομής	Δείκτες Διαδικασίας	Δείκτες Αποτελέσματος
Αποτελεσματικότητα (Effectiveness)		Συμμόρφωση με ιατρικά πρωτόκολλα (μελλοντικός δείκτης)	Ενδονοσοκομειακή θνητότητα μετά από επιλεγμένες διαγνώσεις νόσων (με προτυποποίηση για ηλικία και φύλο)
	Αναλογία ΝοσηλευτικώνΤΕ σε σχέση με το σύνολο του Νοσηλευτικού Προσωπικού		Ενδονοσοκομειακή θνητότητα μετά από επιλεγμένες χειρουργικές επεμβάσεις (με προτυποποίηση για ηλικία και φύλο)
Ασφάλεια Ασθενών (Patient and Staff Safety)		Ορθή Χρήση Περιεγχειρητικής Αντιμικροβιακής Προφύλαξης (PAP)	Ποσοστό νοσοκομειακών λοιμώξεων επί της δύναμης των ασθενών
	Αριθμός ιατρικού προσωπικού/κατ. κλίνη	Συμμόρφωση με τα πέντε βήματα υγιεινής των χεριών (HH compliance)	Λοιμώξεις σχετιζόμενες με κεντρική γραμμή (CLABSI)
	Αριθμός νοσηλευτικού προσωπικού/κατ. κλίνη	Συχνότητα χρήσης παρεμβατικού ιατρικού εξοπλισμού (κεντρικές γραμμές, ουροκαθετήρες, αναπνευστήρες)	Ουρολοιμώξεις σχετιζόμενες με ουροκαθετήρα (CAUTI)
		Συμμόρφωση με τα κριτήρια για την ορθή ταυτοποίηση του ασθενούς - Ποσοστό ασθενών που παρουσίασαν ελλιπή ή και καθόλου ταυτοποίηση	Συμβάντα σχετιζόμενα με μηχανικό αερισμό (VAE)
		Συμμόρφωση με τη λίστα ελέγχου για την ασφάλεια στις χειρουργικές επεμβάσεις	Λοιμώξεις Χειρουργικού Πεδίου (SSI)
		Ποσοστό εμβολιασθέντων εργαζομένων για Γρίπη, Ηπατίτιδα Β	Αριθμός πτώσεων ασθενών
			Αριθμός πτώσεων ασθενών με κάταγμα ισχίου λόγω της πτώση
			Ποσοστό νοσηλευόμενων ασθενών με έλκη πίεσης (επιπολασμός)
			Ποσοστό νοσηλευόμενων ασθενών που ανέπτυξαν νέα έλκη πίεσης κατά τη διάρκεια της νοσηλείας (επίπτωση)
			Ποσοστό ασθενών που επανεισήχθησαν στη ΜΕΘ 48 ώρες μετά την έξοδο τους από αυτή
			Ποσοστό θανάτων ασθενών 72 ώρες μετά την έξοδό τους από τη ΜΕΘ στην οποία νοσηλεύτηκαν
			Μη προγραμματισμένη επανεισαγωγή στο Νοσοκομείο εντός 30 ημερών μετά το εξιτήριο για οποιαδήποτε αιτία μέσω του ΤΕΠ
			Μη προγραμματισμένη επανεισαγωγή στο Νοσοκομείο εντός 30 ημερών μετά το εξιτήριο για (α) καρδιακή ανεπάρκεια (β) στεφανιαία νόσο μέσω ΤΕΠ
			Τραύματα από αιχμηρά αντικείμενα σε εργαζομένους στο χώρο του νοσοκομείου
			Πλήθος εργατικών ατυχημάτων ανά 100 εργαζόμενους
Παραγωγικότητα, επάρκεια παρεχόμενων υπηρεσιών, ορθολογική διαχείριση πόρων και αποδοτικότητα	Ποσοστό κλινών ΜΕΘ στο σύνολο των κλινών του νοσοκομείου	Μέση Διάρκεια Νοσηλείας	
	Ποσοστό κλινών ΜΑΦ στο σύνολο των κλινών του νοσοκομείου	Μέσος ρυθμός εισροής ασθενών	
		Μέσο διάστημα εναλλαγής κλινών	
		Ποσοστό κάλυψης κλινών / Πληρότητα κλινών	
		Αριθμός χειρουργικών επεμβάσεων ανά Χειρουργό	
		Αριθμός χειρουργείων μιας ημέρας στο σύνολο των χειρουργείων	
Προσβασιμότητα σε υπηρεσίες υγείας (για υιοθέτηση και μέτρηση σε επόμενο βήμα)		Μέγιστος χρόνος αναμονής για επιλεγμένες χειρουργικές επεμβάσεις	
		Μέγιστος χρόνος αναμονής για εξέταση στα εξωτερικά ιατρεία	
		Μέγιστος χρόνος αναμονής για διενέργεια ιατρικής εξέτασης	

Ανάπτυξη Δεικτών Ποιότητας στην ΠΦΥ (Μονάδα Υγείας)

ΟΔΙΠΥ

ΠΦΥ: Δείκτες Νοσολογικής Κίνησης

Α) Δείκτες Επισκέψεων (τακτικών, έκτακτων, συνταγογράφησης)

Παράγοντας	Περιγραφή
Άξονας	Παραγωγικότητα, επάρκεια παρεχόμενων υπηρεσιών, ορθολογική διαχείριση πόρων και αποδοτικότητα
Σκεπτικό-Σημασία Χρήσης Δείκτη (Rationale)	Ο δείκτης αυτός βοηθά στην παρακολούθηση της νοσολογικής κίνησης της δομής με βάση τη βαρύτητα των επισκέψεων, με στόχο την παροχή αποτελεσματικότερης, έγκαιρης και συντονισμένης παροχής υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς.
Τρόπος Υπολογισμού (Calculation formula)	$\frac{Αριθμός\ Τακτικών\ Επισκέψεων}{Συνολικός\ Αριθμός\ Επισκέψεων} \times 100$, $\frac{Αριθμός\ Έκτακτων\ Επισκέψεων}{Συνολικός\ Αριθμός\ Επισκέψεων} \times 100$ $\frac{Αριθμός\ Επισκέψεων\ μόνο\ για\ Συνταγογράφηση}{Συνολικός\ Αριθμός\ Επισκέψεων} \times 100$
Αριθμητής (Numerator)	Καταγράφεται ο αριθμός των επισκέψεων ανά είδος (τακτικές, έκτακτες, μόνο για συνταγογράφηση)
Παρονομαστής (Denominator)	Καταγράφεται ο συνολικός αριθμός επισκέψεων στη δομή ΠΦΥ στην περίοδο μελέτης.
Πληθυσμός στόχος (Target population)	Όλοι οι ασθενείς που επισκέπτονται τη δομή ΠΦΥ, καθώς και το προσωπικό της δομής.
Περιοδικότητα (Periodicity)	Μηνιαία καταγραφή
Επιλογή διαστήματος/ημέρας καταγραφής	Κάθε 1η βδομάδα του μήνα γίνεται καταγραφή δεδομένων για τον προηγούμενο μήνα
Βήματα συλλογής δεδομένων (Data collection steps)	**Βήμα 1**: Καταγραφή του αριθμού επισκέψεων ανά είδος για τον αντίστοιχο μήνα μελέτης (κάθε επίσκεψη εμπίπτει σε μία μόνο κατηγορία) **Βήμα 2**: Υπολογισμός του συνολικού αριθμού επισκέψεων στη δομή ΠΦΥ του μήνα αναφοράς **Βήμα 3**: Υπολογισμός του δείκτη συνολικά και ανά ιατρείο **Βήμα 4**: Αποστολή δεδομένων στον ΟΔΙΠΥ στο προκαθορισμένο αρχείο Excel (ή μέσω πλατφόρμας)
Διαχείριση δεδομένων (Notes)	• Σύγκριση των δεικτών σε μηνιαία βάση και παρακολούθηση της τάσης στην πορεία του χρόνου • Γνωστοποίηση των στοιχείων στην Υγειονομική Περιφέρεια • Μελέτη και ανάλυση των αποτελεσμάτων του δείκτη με τη βοήθεια εργαλείων ποιότητας και συγκριτική ανάλυση με τη νοσολογική κίνηση άλλων δομών, σε συνάρτηση με τον αριθμό εργαζομένων • Ανάπτυξη πλάνου δράσεων εστιασμένο στην ενδυνάμωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
Στόχος απόδοσης Συγκριτικό σημείο αναφοράς	Ο εθνικός στόχος απόδοσης δεν είναι καθορισμένος. Κάθε δομή συνίσταται να παρακολουθεί την εξέλιξη του δείκτη διαχρονικά και να διερευνά τυχόν αποκλίσεις από το μέσο όρο της προηγούμενης περιόδου. Δύναται προτυποποίηση του δείκτη ανά χρόνιο νόσημα (άσθμα, διαβήτης, υπέρταση, καρδιακή ανεπάρκεια, πνευμονοπάθεια), φύλο και ηλικία
Πηγή (Sources and further reading)	• Health at a Glance 2019: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing; 2019. https://doi.org/10.1787/4dd50c09-en (https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2019_4dd50c09-en, accessed 20 April 2021) • https://www.who.int/teams/integrated-health-services/health-services-performance-assessment/phc-measurement-framework-and-indicators • Υπουργείο Υγείας, ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 2021 – 2025, Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία 2021-2025 - Εθνικά Σχέδια Δράσης - Υπουργείο Υγείας (moh.gov.gr) • Ιατρική Εταιρεία Αθηνών (Τόμος 28, Τεύχος 1, 2016), Ποιότητα και Αποδοτικότητα στην ΠΦΥ-Αξιολόγηση και σχεδιασμός των παρεχόμενων υπηρεσιών ΠΦΥ

- Δείκτης Νοσολογικής Κίνησης
  (Επισκέψεις/τακτικών, έκτακτων, συνταγογράφησης – Κατ' οίκον Επισκέψεις – Τηλεφωνικές κλήσεις για συμβουλή/τηλεφροντίδα)
- Δείκτες συχνότερων κύριων διαγνώσεων ICD10
- Δείκτης Διακομιδών/Παραπομπών
- **Δείκτες Πρόληψης και προαγωγής της υγείας** (Δείκτες Διακοπής Καπνίσματος – Δείκτες Ελέγχου Παχυσαρκίας – Δείκτες εμβολιαστικής κάλυψης – Οδοντιατρικών πράξεων)
- **Δείκτες Συνταγογράφησης εξετάσεων προσυμπτωματικού ελέγχου**
- Δείκτης Χρόνου ανταπόκρισης τακτικών επισκέψεων
- Δείκτης Ανθρώπινου Δυναμικού
  (Κατανομής προσωπικού υγείας βάσει πληθυσμού ευθύνης – Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης)
- Δείκτες Οικονομικής Κίνησης
- Δείκτες για τον Προσωπικό Ιατρό
  (κάλυψης εγγεγραμμένων πολιτών βάσει πληθυσμού ευθύνης, εφαρμογής Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης)

Ανάπτυξη Δεικτών Ποιότητας στην ΠΦΥ (Προσωπικός Ιατρός)

ΟΔΙΠΥ

Δείκτες Συνταγογράφησης Εμβολίων Γρίπης, Πνευμονιόκοκκου, Τέτανου, HPV, Έρπητα Ζωστήρα

Παράγοντας	Περιγραφή
Άξονας	Ασφάλεια Ασθενών
Σκεπτικό-Σημασία Χρήσης Δείκτη (Rationale)	Σκοπός της μέτρησης των συγκεκριμένων δεικτών είναι η πρόληψη και η αντιμετώπιση νοσημάτων που δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν μόνο με την εφαρμογή άλλων μέτρων δημόσιας υγείας.
Τρόπος Υπολογισμού (Calculation formula)	$\frac{\text{Αριθμός συνταγογραφήσεων εμβολίου Γρίπης}}{\text{Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων πολιτών ανά Προσωπικό Ιατρό}} \times 100$ $\frac{\text{Αριθμός συνταγογραφήσεων εμβολίου Πνευμονιόκοκκου}}{\text{Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων πολιτών ανά Προσωπικό Ιατρό}} \times 100$ $\frac{\text{Αριθμός συνταγογραφήσεων εμβολίου Τετάνου}}{\text{Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων πολιτών ανά Προσωπικό Ιατρό}} \times 100$ $\frac{\text{Αριθμός συνταγογραφήσεων εμβολίου HPV}}{\text{Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων πολιτών ανά Προσωπικό Ιατρό}} \times 100$ $\frac{\text{Αριθμός συνταγογραφήσεων εμβολίου Έρπητα Ζωστήρα}}{\text{Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων πολιτών ανά Προσωπικό Ιατρό}} \times 100$
Αριθμητής (Numerator)	Καταγράφεται ο αριθμός συνταγογραφήσεων για το συγκεκριμένο εμβόλιο στην περίοδο της μελέτης με την ολοκλήρωση των δόσεων, βάσει των ηλικιακών κατηγοριών της εγκυκλίου, ανά Προσωπικό Ιατρό.
Παρονομαστής (Denominator)	Καταγράφεται το άθροισμα των εγγεγραμμένων πολιτών ανά Προσωπικό Ιατρό στην περίοδο μελέτης.
Πληθυσμός στόχος (Target population)	Όλοι οι ενήλικοι εγγεγραμμένοι ασθενείς που επισκέπτονται τη δομή ΠΦΥ στα τακτικά ιατρεία, μόνο για συνταγογράφηση των εμβολίων της Γρίπης, του Πνευμονιόκοκκου, του Τετάνου, HPV και του Έρπητα Ζωστήρα, καθώς και το προσωπικό της δομής.
Περιοδικότητα (Periodicity)	Μηνιαία καταγραφή
Επιλογή διαστήματος/ημέρας καταγραφής	Κάθε 1η βδομάδα του μήνα γίνεται καταγραφή δεδομένων για τον προηγούμενο μήνα
Βήματα συλλογής δεδομένων (Data collection steps)	**Βήμα 1**: Αναδρομική συλλογή του συνολικού αριθμού συνταγογραφήσεων των εμβολίων για τον συγκεκριμένο μήνα μελέτης, ανά Προσωπικό Ιατρό **Βήμα 2**: Υπολογισμός του συνολικού αριθμού των εγγεγραμμένων πολιτών, ανά Προσωπικό Ιατρό του μήνα αναφοράς **Βήμα 3**: Υπολογισμός του δείκτη **Βήμα 4**: Αποστολή δεδομένων στον ΟΔΙΠΥ στο προκαθορισμένο αρχείο excel (ή μέσω πλατφόρμας)
Διαχείριση δεδομένων (Notes)	• Σύγκριση των δεικτών σε μηνιαία βάση και παρακολούθηση της τάσης στην πορεία του χρόνου • Γνωστοποίηση των στοιχείων στη Διοίκηση και στις αρμόδιες θεσμοθετημένες Επιτροπές • Μελέτη και ανάλυση των αποτελεσμάτων του δείκτη με τη βοήθεια εργαλείων ποιότητας με σκοπό την αναζήτηση αιτίων όταν παρατηρείται καθοδική τάση με την πάροδο του χρόνου • Ανάπτυξη πλάνου δράσεων εστιασμένο στη βελτίωση των διαδικασιών που απαιτούνται με απώτερο στόχο την αύξηση του ποσοστού εμβολιασμού.
Στόχος απόδοσης Συγκριτικό σημείο αναφοράς	Παρακολουθώντας την απόδοση σε αυτόν τον τομέα, στοχευθετείται εάν τα προγράμματα προώθησης της εμβολιαστικής κάλυψης έχουν επιτυχία και εάν πρέπει να πραγματοποιηθεί αλλαγή των χρησιμοποιούμενων πρακτικών με στόχο την ασφάλεια των ασθενών. Συνίσταται η παρακολούθηση της εξέλιξης του δείκτη διαχρονικά και η διερεύνηση τυχόν αποκλίσεων από την προηγούμενη περίοδο. Δύναται προτυποποίηση του δείκτη ανά φύλο και ηλικία.
Πηγή (Sources and further reading)	• «Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2024. Χρονοδιάγραμμα και Συστάσεις» 2024 Εγκύκλιος υπ'αριθμ Δ1α/Γ.Π.οικ 14223/7.3.2024 (ΑΔΑ ΨΜ16465ΦΥΟ-ΟΘΚ) Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2024 - Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών (ΕΠΕ) Ενηλίκων - Υπουργείο Υγείας (moh.gov.gr) • «Τροποποίηση Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών Ενηλίκων 2024. Χρονοδιάγραμμα και Συστάσεις» 2024 Εγκύκλιος υπ'αριθμ Δ1α/Γ.Π.οικ 44011/22.8.2024 (ΑΔΑ 6ΑΗΒ465ΦΥΟ-9ΑΗ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2024 - Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών (ΕΠΕ) Ενηλίκων - Υπουργείο Υγείας (moh.gov.gr)

- Δείκτης Τήρησης ΑΗΦΥ
- Δείκτες Επισκέψεων (Επισκέψεις στο ιατρείο για κλινική εξέταση – Κατ' οίκον Επισκέψεις – Τηλεφωνικές κλήσεις για συμβουλή/τηλεφροντίδα)
- Δείκτες συχνότερων κύριων διαγνώσεων ICD10
- Δείκτης Παραπομπών
- **Δείκτες Πρόληψης και προαγωγής της υγείας** (Δείκτες Διακοπής Καπνίσματος – Δείκτες Ελέγχου Παχυσαρκίας – Δείκτες εμβολιαστικής κάλυψης)
- **Δείκτες Συνταγογράφησης εξετάσεων προσυμπτωματικού ελέγχου**
- Δείκτης Χρόνου ανταπόκρισης τακτικών επισκέψεων
- Δείκτης Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
- Δείκτες Εφαρμογής Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης

Δράσεις του ΟΔΙΠΥ

10 Εθνικά Πρότυπα

Κωδικός Προτύπου	Τίτλος Εθνικού Προτύπου Ποιότητας
QP-01	Διακυβέρνηση Ποιότητας και Λογοδοσία
QP-02	Σύστημα Ασφάλειας Ασθενών
QP-03	Αναφορά Συμβάντων, Μάθηση και Βελτίωση
QP-04	Διαχείριση Κινδύνων και Ανάλυση Βασικών Αιτιών (RCA)
QP-05	Πρόληψη και Έλεγχος Λοιμώξεων (IPC)
QP-06	Ασφάλεια Φαρμακευτικής Αγωγής
QP-07	Ασφάλεια Υψηλού Κινδύνου Κλινικών Διεργασιών
QP-08	Συνέχεια και Ολοκλήρωση της Φροντίδας
QP-09	Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
QP-10	Διαχείριση Δεδομένων και Αξιοποίηση Πληροφορίας για τη Βελτίωση της Ποιότητας

10 Κατηγορίες Δεικτών Ασφάλειας, Αποτελεσματικότητας, Αποδοτικότητας

16 Δείκτες Λοιμώξεων

20 Πολιτικές, Διαδικασίες και Εργαλεία Ελέγχου

Σε **10** Νοσοκομεία εφαρμογή προγράμματος Πρόληψης Λοιμώξεων

Εκπαίδευση

- **11** **Κύκλοι στην Πρόληψη και Έλεγχο Λοιμώξεων** 1.500/850 εκπαιδευόμενοι /πιστοποιημένοι
- **7** **Κύκλοι / 7 ΥΠΕ στο Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης** 250 εκπαιδευόμενοι

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
8 Απριλίου 2026 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 58

Άρθρο 52
Δομή του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης της Ποιότητας της Φροντίδας Υγείας και της Ασφάλειας των Ασθενών

1. Στο Υπουργείο Υγείας αναπτύσσεται Εθνικό Σύστημα Διακυβέρνησης της Ποιότητας της Φροντίδας Υγείας και της Ασφάλειας των Ασθενών (Ε.Σ.Δ.Π.Φ.Υ.Α.Α.), το οποίο αποτελεί ένα ενιαίο, σύγχρονο και αποτελεσματικό πλαίσιο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στον τομέα της υγείας. Στόχος του Ε.Σ.Δ.Π.Φ.Υ.Α.Α. είναι η συμβολή στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και στην ενίσχυση της ασφάλειας των ασθενών.

2. Το Ε.Σ.Δ.Π.Φ.Υ.Α.Α. εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από σύμφωνη γνώμη της Κυβερνητικής Επιτροπής Ποιότητας του άρθρου 41 του ν. 5218/2025 (Α' 125), εγκρίνονται και τροποποιούνται η πενταετής Εθνική Στρατηγική για την Ποιότητα της Φροντίδας Υγείας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Ελλάδα, καθώς και τα ετήσια στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια του Ε.Σ.Δ.Π.Φ.Υ.Α.Α..

3. Ως Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του Ε.Σ.Δ.Π.Φ.Υ.Α.Α. ορίζεται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.» του ν. 4715/2020 (Α' 149), η οποία εισηγείται στο Υπουργείο Υγείας τη θέσπιση εξειδικευμένων πολιτικών για τη διασφάλιση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης, στη βάση διαδικασιών και πρωτοκόλλων για την πρόληψη κινδύνων και τη συνεχή βελτίωση της ασφάλειας και της φροντίδας των ασθενών.

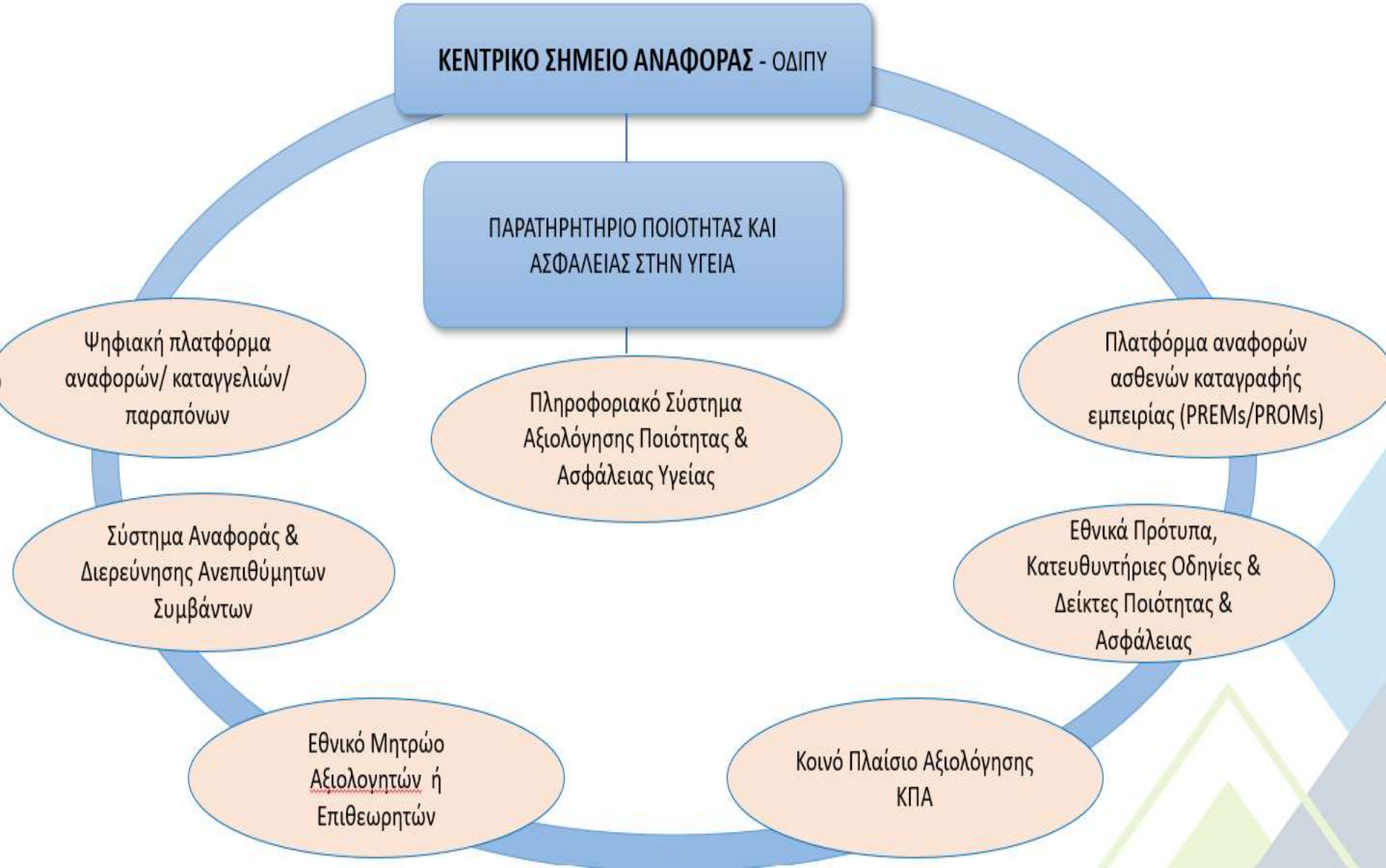
4. Στο πλαίσιο του Ε.Σ.Δ.Π.Φ.Υ.Α.Α., το Υπουργείο Υγείας δύναται, επιπλέον, να αναθέτει στον Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.:

α) την ανάπτυξη, θέσπιση και επικαιροποίηση των εθνικών προτύπων, των κατευθυντήριων οδηγιών και των δεικτών ποιότητας και ασφάλειας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές, σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε.» του άρθρου 43 του ν. 5218/2025,

β) την εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ποιότητα της Φροντίδας Υγείας και την Ασφάλεια των Ασθενών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ληπτών υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4931/2022 (Α' 94), η οποία υποβάλλεται, μετά από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, προς έγκριση στο Υπουργείο Υγείας, και την παρακολούθηση της προόδου της εφαρμογής του, μέσω της σύνταξης ετήσιων εκθέσεων προόδου,

γ) την εκπόνηση των ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων δράσης για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ποιότητα της Φροντίδας Υγείας και την Ασφάλεια των Ασθενών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ληπτών υπηρεσιών υγείας, και την εισήγηση για την έγκρισή τους προς τον Υπουργείο Υγείας,

Εθνικό Σύστημα Διακυβέρνησης της Ποιότητας της Φροντίδας και της Ασφάλειας των Ασθενών



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

8 Απριλίου 2026 | ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ | Αρ. Φύλλου 58

Άρθρο 54

Διαδικασία αναφοράς και διερεύνησης ανεπιθύμητων συμβάντων για την ασφάλεια των ασθενών

1. Για την εφαρμογή του παρόντος ως ανεπιθύμητο συμβάν για την ασφάλεια των ασθενών νοείται κάθε μη προγραμματισμένο ή απροσδόκητο γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει ή οδήγησε σε βλάβη κατά την παροχή υπηρεσιών υγείας και περιλαμβάνει σφάλματα που προκάλεσαν βλάβη, σφάλματα που παρά λίγο δεν προκάλεσαν βλάβη και επικίνδυνες συνθήκες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε βλάβη.

2. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης της Ποιότητας της Φροντίδας Υγείας και της Ασφάλειας των Ασθενών (Ε.Σ.Δ.Π.Φ.Υ.Α.Α.), θεσπίζεται διαδικασία Αναφοράς και Διερεύνησης Ανεπιθύμητων Συμβάντων για την Ασφάλεια των Ασθενών, η οποία διενεργείται από την Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε., ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, ως υπευθύνου επεξεργασίας, σύμφωνα με τις περ. 7) και 8) του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, Γ.Κ.Π.Δ., L 119).

3. Οι αναφορές ανεπιθύμητων συμβάντων είναι προσβάσιμες σε όλους τους παρόχους υπηρεσιών υγείας.

4. Υπεύθυνος για την αναφορά είναι ο επαγγελματίας υγείας ή ο εργαζόμενος σε πάροχο υπηρεσιών υγείας, στην αντίληψη του οποίου υπέπεσε, με οποιονδήποτε τρόπο, το ανεπιθύμητο συμβάν.

5. Η αναφορά γίνεται επώνυμα ή ανώνυμα προς τον αρμόδιο κατά περίπτωση Υπεύθυνο Ποιότητας και Ασφάλειας (Υ.Π.Α.), με σχετική καταχώρηση σε ψηφιακό έντυπο καταγραφής. Βάσει αυτής διενεργείται τοπική διερεύνηση από τα αρμόδια όργανα του παρόχου υπηρεσιών υγείας. Τα δεδομένα τυποποιούνται βάσει εθνικού προτύπου καταγραφής. Κάθε Υ.Π.Α. έχει πρόσβαση στα δεδομένα αρμοδιότητάς του, προκειμένου να υποβάλλει αναφορές συμβάντων στον Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε., και στην οικεία Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.Πε.), καθημερινά ή σε άλλα προκαθορισμένα τακτά χρονικά διαστήματα. Η αναφορά ανεπιθύμητου συμβάντος δεν δύναται να επιφέρει δυσμενή μεταχείριση σε βάρος του αναφέροντος, εφόσον αυτή είναι αληθής και πραγματοποιείται καλόπιστα.

6. Το Παρατηρητήριο Ποιότητας και Ασφάλειας της Υγείας (Π.Π.Α.Υ.) πραγματοποιεί, για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, ως υπευθύνου επεξεργασίας, ταξινόμηση συμβάντων, ανάλυση συστημικών αιτίων, στατιστική επεξεργασία και ανίχνευση προτύπων.

7. Η διερεύνηση των συμβάντων από τον Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε. διέπεται από τις αρχές, της εμπιστευτικότητας και της αποτροπής της δυσμενούς μεταχείρισης του αναφέροντος και δεν αποδίδει υπαιτιότητα ούτε συνιστά πειθαρχική ή ποινική διαδικασία. Τα αποτελέσματα της διερεύνησης αξιοποιούνται για τη βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας υγείας και της ασφάλειας των ασθενών κατά τη σύνταξη των εκθέσεων, εισηγήσεων και αναλύσεων του Π.Π.Α.Υ. και δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν αυτοτελώς ως αποδεικτικό μέσο σε πειθαρχική ή ποινική διαδικασία.

8. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε., καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι οργάνωσης και λειτουργίας της Διαδικασίας Αναφοράς και Διερεύνησης Ανεπιθύμητων Συμβάντων, και ιδίως η διαδικασία υποβολής, καταγραφής, διαχείρισης, ανάλυσης και διερεύνησης αναφορών ανεπιθύμητων συμβάντων, τα αρμόδια όργανα και οι ρόλοι τους σε κάθε στάδιο, οι κανόνες εμπιστευτικότητας, ανωνυμοποίησης και ψευδωνυμοποίησης, τα ειδικότερα δικαιώματα

Σύστημα Νοσοκομειακής Φροντίδας στο Σπίτι (ΝΟΣΠΙ - Hospital at Home)

ΟΔΙΠΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Η νοσηλεία στο σπίτι

Δράση χρηματοδοτούμενη από RRF

Παροχή ασφαλούς, μακροχρόνιας, ολοκληρωμένης, εξατομικευμένης ιατρονοσηλευτικής φροντίδας κατ' οίκον για ασθενείς που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια ένταξης.
Οι Υπηρεσίες θα παρέχονται μέσω ενός οργανωμένου δικτύου Κέντρων Αναφοράς, στελεχωμένων από εξειδικευμένο προσωπικό.

Προσδοκώμενα οφέλη:

- Βελτίωση της ποιότητα ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους.
- Μείωση του κόστους φροντίδας για τους ασθενείς και τις οικογένειες τους.
- Μείωση χρόνου νοσηλείας - αποσυμφόρηση των τριτοβάθμιων κέντρων παροχής φροντίδας - εξοικονόμηση πόρων - μείωση των δεικτών λοίμωξης

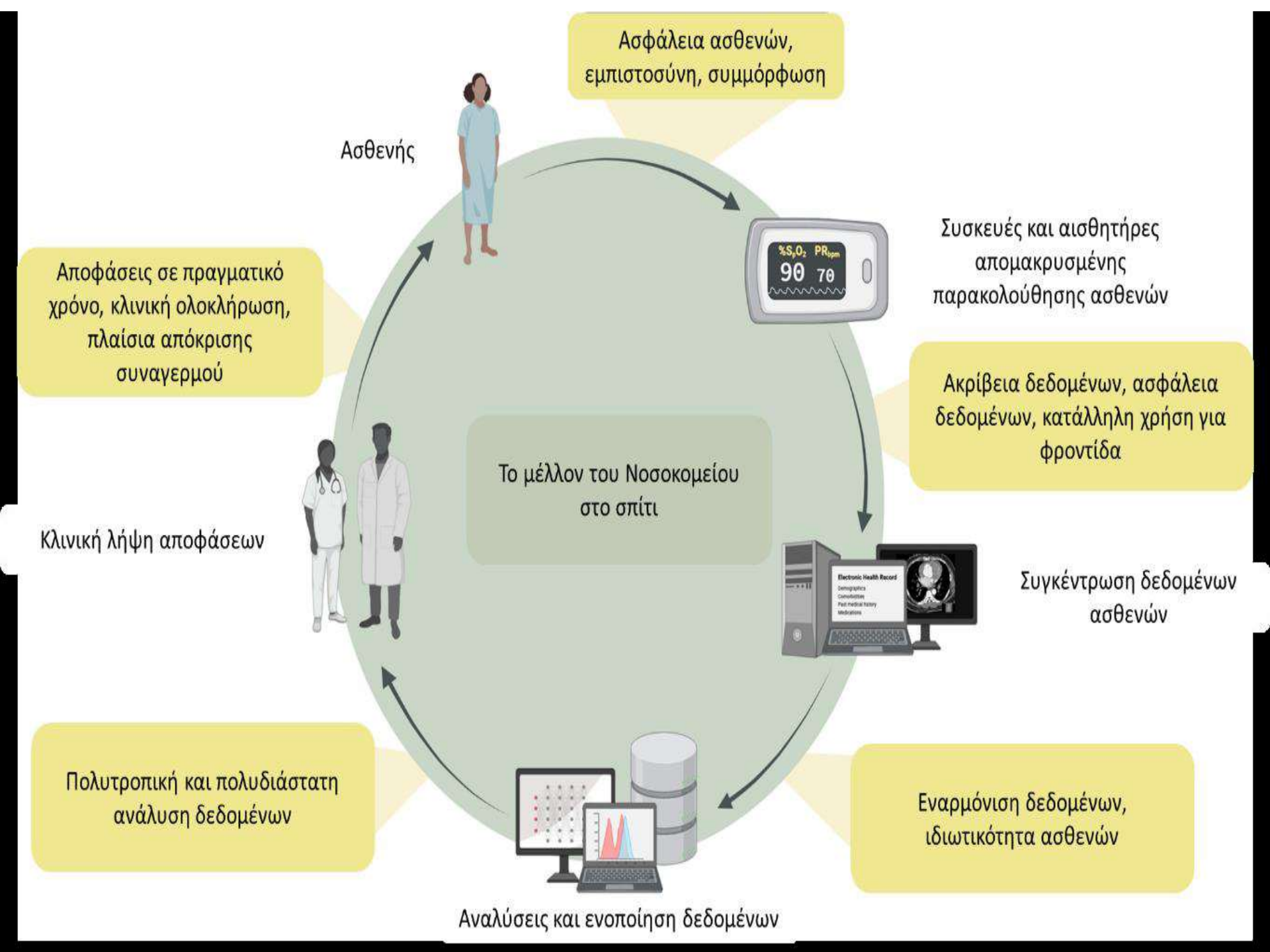
Συνεργασία με 3 ΕΛΚΕ Πανεπιστημίων για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων θεωρητικής και πρακτικής άσκησης:

- ΕΛΚΕ Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: θεωρητική και πρακτική άσκηση των Ιατρών και αναβάθμιση δεξιοτήτων Φροντιστών Παίδων και Ενηλίκων
- ΕΛΚΕ Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών: θεωρητική και πρακτική άσκηση Νοσηλευτών & υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων σχετικών με τη κατάρτιση ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και φροντιστών για ογκολογικούς ασθενείς
- ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: εκπαίδευση Ιατρών & Νοσηλευτών στα ψηφιακά εργαλεία

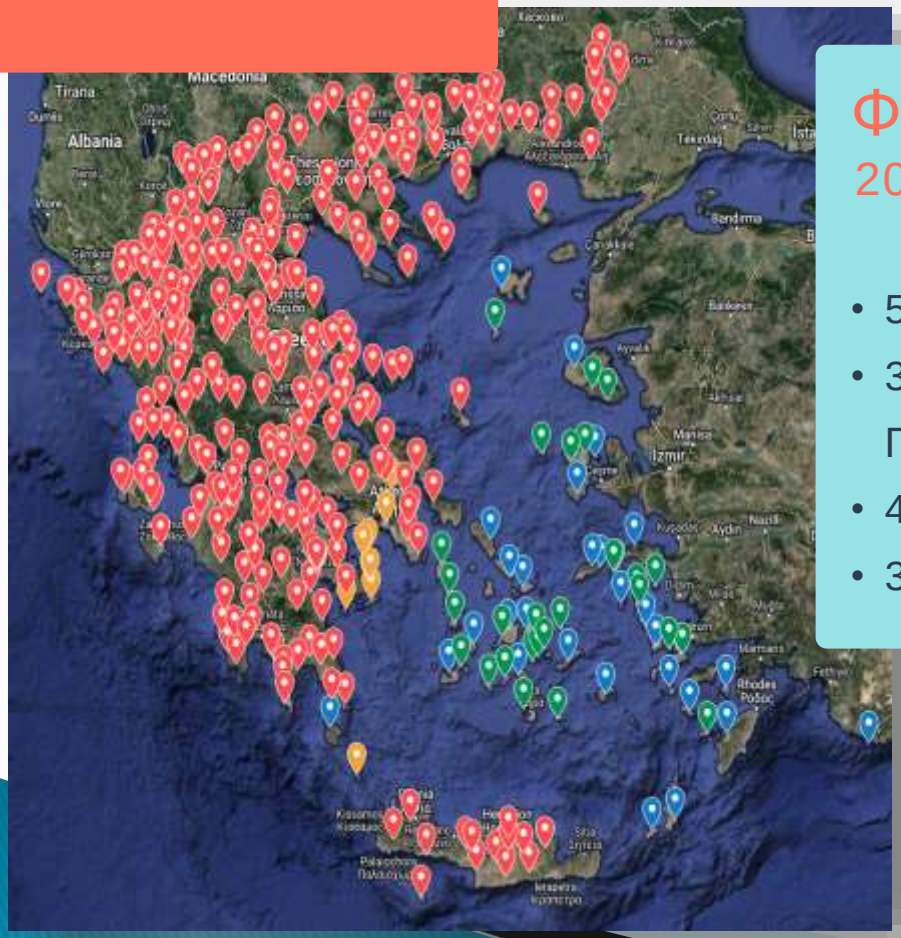
12 Κέντρα Αναφοράς

- Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»
- Γενικό-Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας»
- Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ)
- Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
- Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»
- Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
- Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
- Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
- Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
- Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών
- Μεταξά Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά
- Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΝΟΣΠΙ | ΟΔΙΠΥ


Ασφάλεια ασθενών, εμπιστοσύνη, συμμόρφωση
Ασθενής
Συσκευές και αισθητήρες απομακρυσμένης παρακολούθησης ασθενών
Ακρίβεια δεδομένων, ασφάλεια δεδομένων, κατάλληλη χρήση για φροντίδα
Συγκέντρωση δεδομένων ασθενών
Εναρμόνιση δεδομένων, ιδιωτικότητα ασθενών
Αναλύσεις και ενοποίηση δεδομένων
Πολυτροπική και πολυδιάστατη ανάλυση δεδομένων
Κλινική λήψη αποφάσεων
Αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο, κλινική ολοκλήρωση, πλαίσια απόκρισης συναγερμού
Το μέλλον του Νοσοκομείου στο σπίτι
Electronic Health Record

Εθνική Επέκταση



4

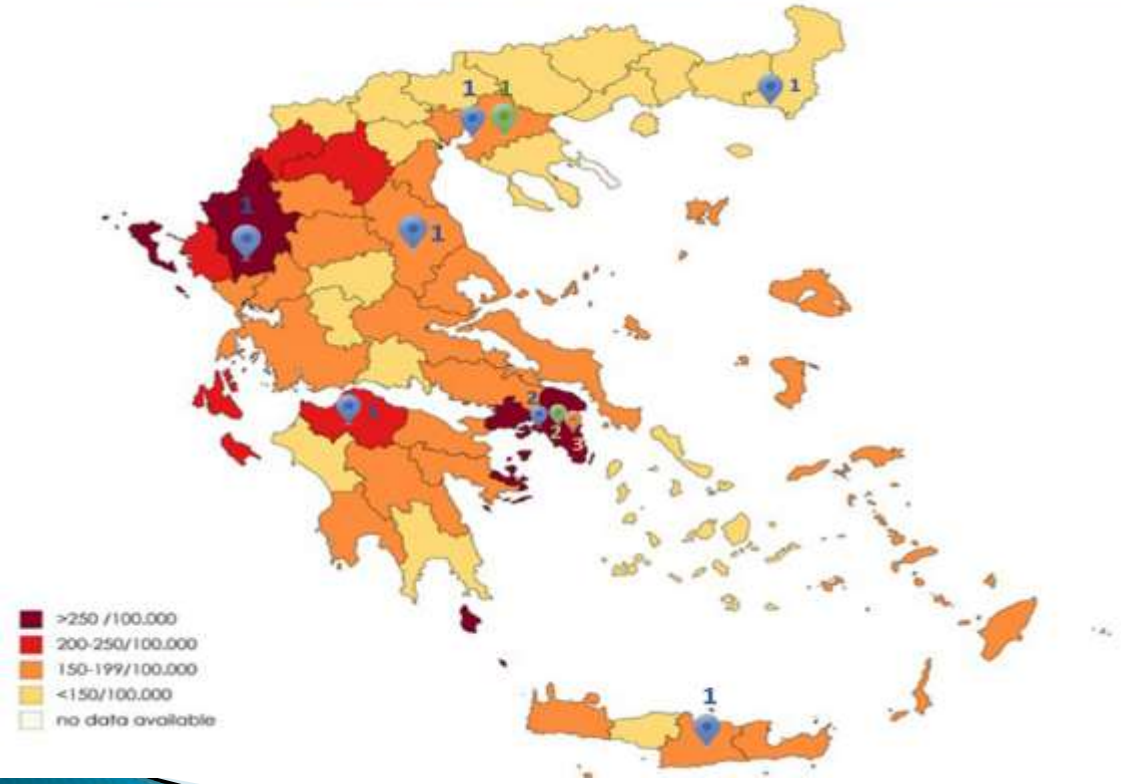
Φάση 4
2024

- 58 Νοσοκομεία
- 378 Δομές ΠΦΥ (ΚΥ, ΠΠΙ & ΠΙ)
- 435 Σταθμοί Τηλεϊατρικής
- 3.180 Homecare

Δίκτυα Ολοκληρωμένης Φροντίδας στο μονοπάτι των ασθενών: Η περίπτωση της πολλαπλής σκλήρυνσης

οδιπυ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Το Δίκτυο των 14 Κέντρων Πολλαπλής Σκλήρυνσης θα καλύψει τις ανάγκες του πληθυσμού διασφαλίζοντας ισότιμη και έγκαιρη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και φροντίδας



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
- Β΄ Νευρολογική Παν/κη- ΑΧΕΠΑ Παν/κο ΓΝ. Θεσσαλονίκης
- Νευρολογική Παν/κη- Παν/κο ΓΝ Λάρισας
- Α' Νευρολογική Παν/κη- Παν/κο ΓΝ Αιγινήτειο
- Β΄ Νευρολογική Παν/κη- Παν/κο ΓΝ. Αττικόν
- Νευρολογική Παν/κη- Παν/κο ΓΝ Αλεξανδρούπολης
- Νευρολογική Παν/κη- Παν/κο ΓΝ Πατρών
- Νευρολογική Παν/κη- Παν/κο ΓΝ Ηρακλείου
- Νευρολογική Παν/κη- Παν/κο ΓΝ Ιωαννίνων

ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
- Νευρολογική- ΓΝ. Ευαγγελισμός
- Νευρολογική- ΓΝ. Γ. Γεννηματάς
- Νευρολογική- ΓΝ. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
- Νευρολογική- 251 ΓΝ. Αεροπορίας
- Νευρολογική- Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
- Νευρολογική- 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσ. Αθηνών

ΟΔΙΠΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
HELLENIC THORACIC SOCIETY

HPI
HEALTH POLICY INSTITUTE

ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟΥ

μετά από νοσηλεία για παρόξυνση ΧΑΠ

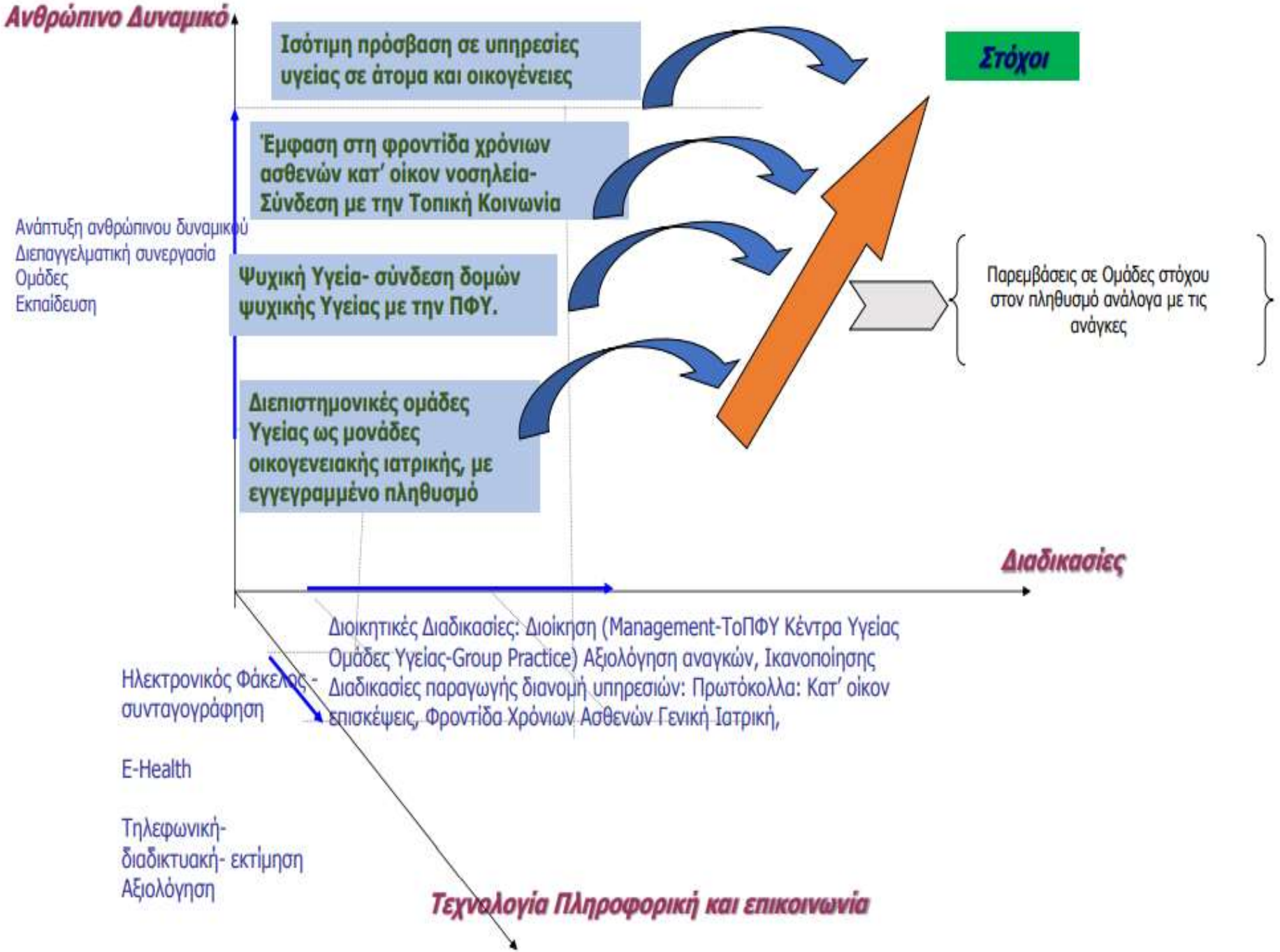
ΟΔΙΠΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Orphanet Greece



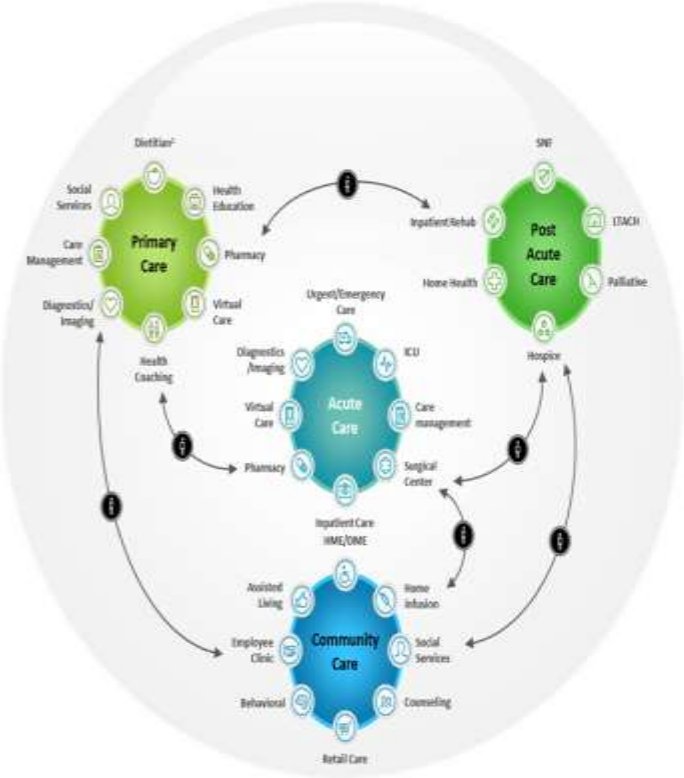
Ψηφιακή Πύλη Σπάνιων Νοσημάτων

Ο Ο.ΔΙ.Π.Υ. αποτελεί τον εθνικό εκπρόσωπο της πλατφόρμας Orphanet στην Ελλάδα, με στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής πύλης και τη διασύνδεση της επιστημονικής κοινότητας, των ασθενών και των φορέων υγείας.


Ανθρώπινο Δυναμικό
Ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας σε άτομα και οικογένειες
Στόχοι
Έμφαση στη φροντίδα χρόνιων ασθενών κατ' οίκον νοσηλεία- Σύνδεση με την Τοπική Κοινωνία
Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού
Διεπαγγελματική συνεργασία
Ομάδες
Εκπαίδευση
Ψυχική Υγεία- σύνδεση δομών ψυχικής Υγείας με την ΠΦΥ.
Παρεμβάσεις σε Ομάδες στόχου στον πληθυσμό ανάλογα με τις ανάγκες
Διεπιστημονικές ομάδες Υγείας ως μονάδες οικογενειακής ιατρικής, με εγγεγραμμένο πληθυσμό
Διαδικασίες
Διοικητικές Διαδικασίες: Διοίκηση (Management-ΤοΠΦΥ Κέντρα Υγείας Ομάδες Υγείας-Group Practice) Αξιολόγηση αναγκών, Ικανοποίησης
Διαδικασίες παραγωγής διανομή υπηρεσιών: Πρωτόκολλα: Κατ' οίκον επισκέψεις, Φροντίδα Χρόνιων Ασθενών Γενική Ιατρική,
Ηλεκτρονικός Φάκελος - συνταγογράφηση
E-Health
Τηλεφωνική- διαδικτυακή- εκτίμηση Αξιολόγηση
Τεχνολογία Πληροφορική και επικοινωνία

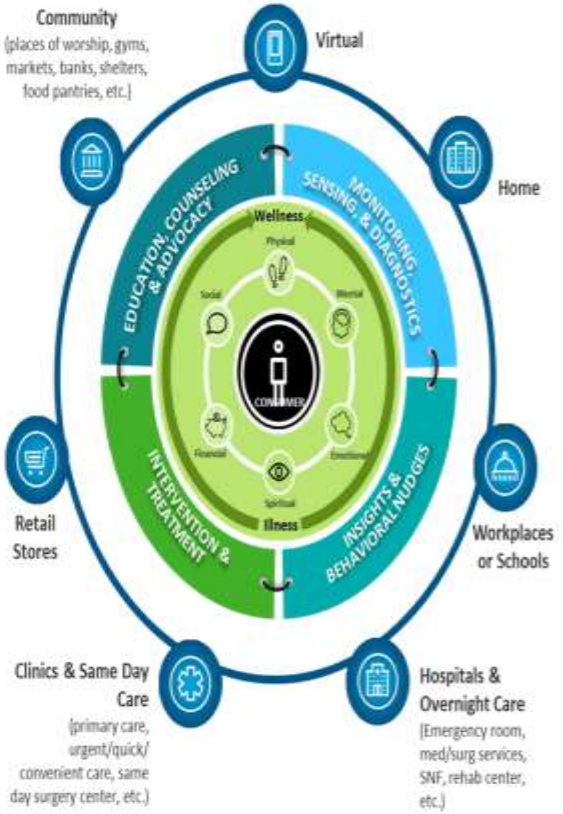
… και στα Νέα Μοντέλα Φροντίδας

Σημερινή Κατάσταση
Μοντέλο Υπηρεσιών Υγείας



Οι **Υπηρεσίες Υγείας** σήμερα είναι ακόμη σχεδιασμένες **γύρω από τους παρόχους.** Κατ' επέκταση, οι εμπειρίες των χρηστών **εμφανίζονται αποσυνδεδεμένες** και **δεν παρουσιάζουν αλληλεπιδράσεις** μεταξύ τους.

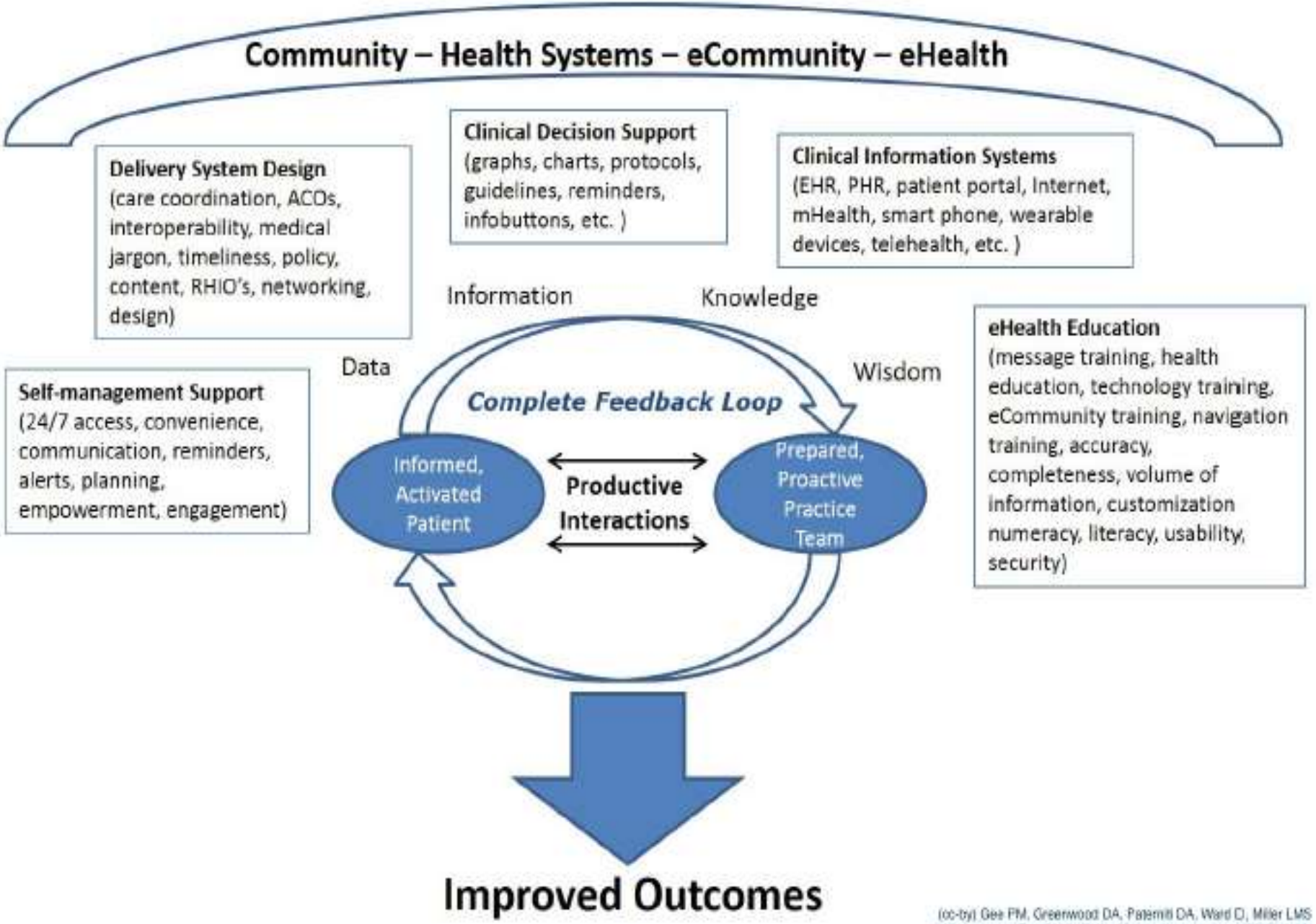
Μελλοντική Κατάσταση
Μοντέλο Υπηρεσιών Υγείας



Οι **Υπηρεσίες Υγείας** στο άμεσο μέλλον θα είναι σχεδιασμένες **γύρω από τον χρήστη** και θα είναι εναρμονισμένες **γύρω από την κάλυψη των αναγκών** του. Οι εμπειρίες θα είναι απρόσκοπτες και **θα υπάρχει ολοκληρωμένη διασύνδεση** μεταξύ των περιοχών.

Πηγή: Deloitte Development LLC.

The eHealth Enhanced Chronic Care Model (eCCM)



(cc-by) Gee PM, Greenwood DA, Paterniti DA, Ward D, Miller LMS
J Med Internet Res 2015;17(4):e86. http://www.jmir.org/2015/4/e86/

Από την αισιοδοξία στα αποτελέσματα

Σκεφθείτε πέρα από την τεχνολογία

Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό

ροή εργασιών & διαχείριση αλλαγών

Αντιμετωπίστε την AI ως μετασχηματισμό

Αποφάσεις, ρόλοι, λογοδοσία

Κερδίστε την εμπιστοσύνη μέσω αποδείξεων

Μέτρηση εμπειρίας & αποτελεσμάτων

ασθενών & επαγγελματιών υγείας

Χρησιμοποιείστε τη διακυβέρνηση για να επιτρέψετε την υιοθέτηση

Συνεχής διασφάλιση, εποπτεία, ισότητα

στην κλινική πράξη

- Από ένα **Ιατροκεντρικό Μοντέλο Άσκησης Ιατρικής** που εστιάζει στη νόσο ως μια καθαρά βιολογική ή μηχανική βλάβη του οργανισμού που απαιτεί επιδιόρθωση, με τον ιατρός να κατέχει την απόλυτη γνώση, εξουσία και τον πλήρη έλεγχο των αποφάσεων και τον ασθενή να αντιμετωπίζεται κυρίως ως παθητικός δέκτης θεραπείας, με κύρια υποχρέωση τη συμμόρφωση στις οδηγίες.

- Με κύρια χαρακτηριστικά της άσκησης την **μονόδρομη επικοινωνία** (η ροή πληροφοριών κατευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά από τον ιατρό προς τον ασθενή), τον **κατακερματισμό της φροντίδας** (με έμφαση στην εξειδίκευση ανά όργανο ή σύστημα, παραβλέποντας τη συνολική εικόνα του ατόμου) και την **εστίαση στα συμπτώματα**.

- Εξαιρετικά αποτελεσματικό στην επείγουσα ιατρική, με επιστημονική ακρίβεια και σαφήνεια ρόλων.

- Σε ένα **Ασθενοκεντρικό Μοντέλο** που θέτει τις ανάγκες, τις αξίες, τις προτιμήσεις και τις εμπειρίες του ασθενούς στο επίκεντρο της φροντίδας υγείας, με τον ασθενή να μην αντιμετωπίζεται απλώς ως ένα σύνολο συμπτωμάτων ή μια βιολογική βλάβη, αλλά ως μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, που αντιμετωπίζεται ως ισότιμος συνεργάτης στη διαχείριση της υγείας του, ενθαρρύνοντας την αυτονομία και την υπευθυνότητα.
- Σε ένα Μοντέλο **Κοινής Λήψης Αποφάσεων (Shared Decision-Making)**
- Με βασικούς πυλώνες:
  - **Σεβασμός στις Αξίες & Προτιμήσεις** με ενσωμάτωση του πολιτισμικού υπόβαθρου, των πεποιθήσεων και των προσωπικών στόχων του ασθενούς στο θεραπευτικό πλάνο.
  - **Συντονισμός & Ολοκλήρωση** με στενή συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ειδικοτήτων για την αποφυγή κατακερματισμού της φροντίδας.
  - **Πληροφόρηση & Εκπαίδευση** ώστε ο ασθενής να μπορεί να λάβει τεκμηριωμένες αποφάσεις.
  - **Συναισθηματική Υποστήριξη**

- Υποστηριζόμενο από ένα **Τοποκεντρικό Μοντέλο Άσκησης Ιατρικής (Place-Based Care)** σχεδιάζοντας την φροντίδα με βάση την κοινότητα.

- Με κύρια χαρακτηριστικά και με έμφαση στους **κοινωνικούς προσδιοριστές (SDOH)**:
  - **Ενσωμάτωση στην Κοινότητα:** Οι δομές υγείας λειτουργούν ως οργανικό κομμάτι της.
  - **Διατομεακή Συνεργασία:** Άμεση σύνδεση των γιατρών με τοπικούς φορείς, σχολεία, κοινωνικούς λειτουργούς και οργανώσεις.
  - **Προληπτική Παρέμβαση:** Δράσεις στο περιβάλλον διαβίωσης για την πρόληψη των ασθενειών.

- Η **Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ)**, με τον Γενικό/Οικογενειακό Ιατρό και την Ομάδα Υγείας να αποτελεί το φυσικό και ιδανικό πεδίο εφαρμογής του Μοντέλου, καθώς αποτελεί την πρώτη επαφή του πολίτη με το σύστημα υγείας μέσα στην ίδια του την κοινότητα, χαρτογραφώντας τις ανάγκες ανά περιοχή.

Οι προκλήσεις

- **Απαιτήσεις σε Χρόνο:** Η ασθενοκεντρική επικοινωνία απαιτεί περισσότερο χρόνο κατά την κλινική εξέταση, κάτι που πιέζει τα δημόσια συστήματα υγείας.
- **Αλλαγή Νοοτροπίας:** Απαιτείται εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στις δεξιότητες επικοινωνίας (ενσυναίσθηση, ενεργητική ακρόαση) και απεμπλοκή από την παραδοσιακή αυθεντία.

- Το ασθενοκεντρικό μοντέλο δεν καταργεί την ιατρική επιστήμη, αντίθετα, την εξανθρωπίζει, μετατρέποντας την ιατρική πράξη από **«θεραπεύω μια νόσο»** σε **«φροντίζω έναν άνθρωπο»**.



- *Μήπως βοηθώντας τους άλλους, αποφεύγουμε να πληγώνουμε τον εαυτό μας;*

Ριουσούκε Χαμαγκούτσι, «Έτσι ξαφνικά»

Σας ευχαριστώ πολύ

ethireos@gmail.com